avitaserena.

GUIDE COMPLET

SIBO : comprendre, tester, agir.

Le guide pour comprendre ce qui se passe dans votre ventre, préparer un test fiable et construire avec les bons interlocuteurs la suite de votre parcours.

Sabrina Castelli · Praticienne en naturopathie
Santé digestive et hormonale des femmes · Porto-Vecchio, Corse
avitaserena.com

SOMMAIRE

Ce que vous allez trouver ici.

Introduction
Pourquoi ce guide existe, et comment l'utiliser

PARTIE 1 · COMPRENDRE

1 Ce qui se passe dans l'intestin grêle
2 Pourquoi cela arrive : les protections et leurs failles
3 Les trois profils de gaz
4 SIBO, intestin irritable et autres explications
5 SIBO et hormones : ce que l'on sait, et ce que l'on suppose

PARTIE 2 · TESTER

6 Le test respiratoire, pas à pas
7 Lire un résultat, et savoir ce qu'il ne dit pas
Fiche imprimable : lire mes résultats

PARTIE 3 · AGIR, AVEC MÉTHODE

8 La logique d'un accompagnement
9 L'alimentation : ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas
10 Le rythme des repas et le nettoyage de l'intestin
11 Stress, nerf vague et sommeil
12 Compléments et probiotiques : pourquoi cela ne se décide pas dans un guide
13 La rechute, et comment la prévenir

PARTIE 4 · VOTRE HISTOIRE

Fiche : ma frise du premier domino
Fiche : mon journal de 7 jours
Fiche : préparer mon rendez-vous

Glossaire · Sources

INTRODUCTION

Pourquoi ce guide existe.

Parce que l'on m'a longtemps répondu que tout allait bien, alors que mon ventre disait le contraire.

J'ai travaillé pendant douze ans dans la recherche et le développement de compléments alimentaires pour une marque française. Quand mes propres symptômes sont apparus, j'avais des bases scientifiques solides, et pourtant il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait. La naturopathie m'a aidée à y voir clair et à traverser mon propre SIBO. J'en ai fait mon métier pour accompagner d'autres femmes à mon tour. Je suis certifiée praticienne en naturopathie et j'ai suivi des modules de spécialisation chez DFM Formations, sur la santé des femmes, les hormones et la sphère digestive.

Ce guide n'est pas un protocole. Il vous donne **les clés de compréhension** : ce qui se passe dans l'intestin, pourquoi un test est utile, comment le préparer, comment lire un résultat sans le surinterpréter, et quelles questions poser. Il explique chaque fois le pourquoi, parce que comprendre son corps est la meilleure base pour décider avec les bons interlocuteurs.

CE QUE CE GUIDE NE FAIT PAS

Il ne pose pas de diagnostic, ne remplace ni votre médecin ni un gastro-entérologue, et ne vous prescrit ni traitement, ni complément, ni régime. Les stratégies précises se construisent à partir de votre histoire, de vos examens et de vos traitements en cours. Un guide écrit pour tout le monde ne peut pas le faire sans risque.

CONSULTEZ SANS ATTENDRE SI VOUS AVEZ

- un amaigrissement que vous n'expliquez pas ;
- du sang dans les selles, ou des selles noires ;
- une anémie découverte à une prise de sang ;
- de la fièvre, des vomissements répétés, ou une difficulté à avaler ;
- des douleurs qui vous réveillent la nuit ;
- des symptômes digestifs nouveaux après 50 ans, ou des antécédents familiaux de cancer colorectal, de maladie cœliaque ou de maladie de Crohn.

Ces signes demandent un avis médical rapide. Ils ne relèvent pas d'un guide.

PARTIE 1 · COMPRENDRE

Chapitre 1
Ce qui se passe dans l'intestin grêle.

Un excès de bactéries, au mauvais endroit.

L'intestin grêle est la partie de l'intestin comprise entre l'estomac et le côlon. Il mesure plusieurs mètres (environ six, selon les sources). C'est là que vous absorbez la plupart des nutriments : sucres, protéines, graisses, vitamines, minéraux. Il est normalement peu peuplé en bactéries. Le côlon, lui, en héberge des milliards, et c'est normal et utile : elles y digèrent les fibres et produisent des substances bénéfiques.

On parle de SIBO (**Small Intestinal Bacterial Overgrowth**) quand ces bactéries sont trop nombreuses dans l'intestin grêle. La définition de référence est une culture d'un prélèvement de liquide intestinal montrant au moins 1 000 bactéries par millilitre. Ce prélèvement étant rare et invasif, on utilise en pratique le test respiratoire (chapitre 6).

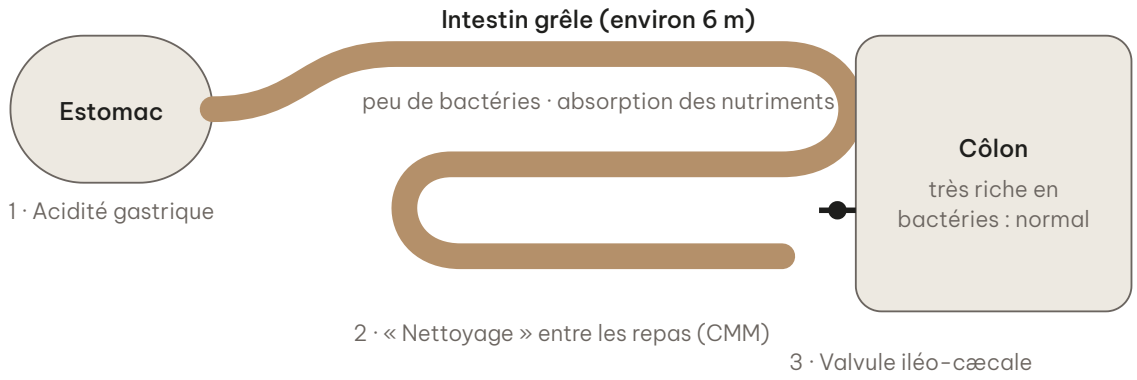


Schéma simplifié. Trois protections gardent l'intestin grêle peu peuplé : l'acidité de l'estomac, le « nettoyage » entre les repas et la valvule iléo-cæcale.

Pourquoi cela donne des symptômes

Les bactéries se nourrissent des glucides que vous mangez. Quand elles sont trop nombreuses dans l'intestin grêle, elles en fermentent une partie avant que vous l'ayez absorbée. Cette fermentation produit des gaz : de l'hydrogène, du méthane ou du sulfure d'hydrogène. L'intestin grêle est étroit et riche en terminaisons nerveuses : peu de gaz suffisent à provoquer un ventre tendu, des douleurs, des nausées ou un changement de transit.

Deux autres effets sont décrits, avec un niveau de preuve variable selon les cas. Premièrement, l'excès de bactéries peut gêner l'absorption de certains nutriments : des carences en vitamine B12 ou en fer sont décrites chez certaines personnes, ce qui peut contribuer à de la fatigue, sans qu'on puisse l'attribuer au SIBO sans bilan. Deuxièmement, l'idée que la paroi de l'intestin deviendrait plus perméable et déclencherait une inflammation générale est une hypothèse de recherche. Elle est plausible, mais pas démontrée de façon définitive chez l'humain.

> **POURQUOI ON DIT « CONSÉQUENCE »**
>
> Les bactéries n'envahissent pas un intestin dont les protections fonctionnent. Dans la plupart des cas, le SIBO est **la conséquence** de quelque chose qui a affaibli ces protections. C'est pourquoi la question utile n'est pas seulement « comment éliminer les bactéries ? », mais « qu'est-ce qui les a laissées s'installer ? ».

PARTIE 1 · COMPRENDRE

Chapitre 2
Pourquoi cela arrive : les

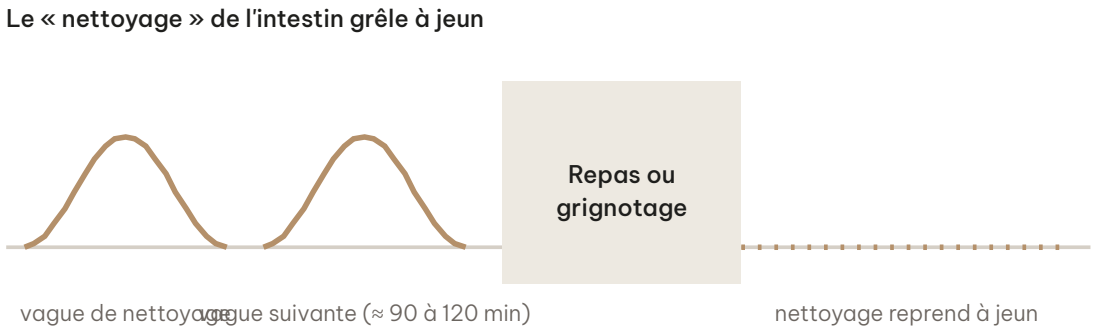
protections et leurs failles.

Il y a presque toujours un « premier domino ».

Les trois protections

- **L'acidité de l'estomac** élimine une grande partie des bactéries avalées. Si elle diminue (traitement prolongé contre l'acidité, certaines maladies de l'estomac), davantage de bactéries survivent et descendent.
- **Le complexe moteur migrant (CMM)** est la vague de contractions qui balaie l'intestin grêle à jeun, environ toutes les 90 à 120 minutes. Il fait avancer le contenu de l'intestin, bactéries comprises. Il est interrompu par chaque prise alimentaire.
- **La valvule iléo-cæcale** sépare l'intestin grêle du côlon et limite la remontée du contenu du côlon. Son absence, après une chirurgie, favorise le SIBO.

Il y a aussi les sécrétions de bile et d'enzymes digestives, et le système immunitaire de l'intestin, qui contribuent à garder les bactéries sous contrôle.



Le nettoyage de l'intestin grêle a lieu à jeun. Un repas ou un grignotage l'interrompt. Il reprend ensuite, après une période sans manger.

Ce qui peut faire faiblir ces protections

Les recommandations médicales (American College of Gastroenterology, 2020) citent comme facteurs favorisants :

- des médicaments : inhibiteurs de la pompe à protons, opioïdes, certains traitements ralentissant le transit. Le lien avec les inhibiteurs de la pompe à protons est qualifié de « complexe » : toutes les études ne le retrouvent pas ;
- des troubles de la motilité, liés par exemple au diabète ou à certaines maladies du tissu conjonctif ;
- une chirurgie abdominale, des adhérences, des anomalies anatomiques, l'ablation de la valvule iléo-cæcale ;
- une faible acidité de l'estomac, y compris d'origine auto-immune ;
- certaines maladies digestives ou immunitaires : maladie cœliaque, maladie de Crohn, déficits immunitaires ;
- l'âge avancé, et le sexe féminin.

D'autres pistes sont explorées, avec des niveaux de preuve plus faibles : une infection digestive sévère dans le passé, un trouble thyroïdien, un stress chronique qui perturbe la régulation nerveuse de l'intestin. Elles méritent d'être posées en consultation, sans être présentées comme des certitudes.

À PROPOS DE L'HYPOTHÈSE POST-INFECTIEUSE

Après certaines gastro-entérites, une hypothèse suggère que des anticorps dirigés contre une toxine bactérienne pourraient aussi cibler une protéine de la motricité de l'intestin (la vinculine). Elle repose en partie sur des modèles animaux et sur des études menées chez des personnes ayant un syndrome de l'intestin irritable de type diarrhéique. Elle reste une hypothèse : elle ne permet pas d'expliquer à elle seule un SIBO, ni de dire quel type de SIBO on a.

PARTIE 1 · COMPRENDRE

Chapitre 3
Les trois profils de gaz.

Selon les bactéries ou archées présentes, ce ne sont pas les mêmes gaz.

GAZ PRODUIT	CE QUE L'ON SAIT	CE QU'IL FAUT GARDER EN TÊTE
Hydrogène (H_2)	Le plus souvent mesuré. Le test respiratoire s'appuie sur son augmentation. Il est volontiers associé à un transit accéléré.	Un transit accéléré n'est pas spécifique : il ne permet pas de conclure.
Méthane (CH_4)	Produit par des archées (micro-organismes distincts des bactéries). Les spécialistes préfèrent le terme IMO (**Intestinal Methanogen Overgrowth**). Il est volontiers associé à la constipation, le méthane pouvant ralentir le transit.	Les recommandations proposent de rechercher le méthane chez les personnes constipées. Il n'est pas exact de « diagnostiquer » un type d'après les seuls symptômes.
Sulfure d'hydrogène (H_2S)	Un troisième profil est décrit, associé à certaines bactéries. Les selles très odorantes sont souvent citées.	Les tests respiratoires courants ne mesurent pas ce gaz. Un test « normal » ne l'exclut donc pas, et les connaissances sont plus limitées.

POURQUOI LE TYPE COMPTE

Le gaz mesuré peut orienter les choix thérapeutiques et leur surveillance. Cela explique pourquoi on cherche d'abord à mesurer plutôt qu'à deviner. Mais le type n'est qu'une information parmi d'autres : il ne remplace pas la recherche de la cause.

Pourquoi les symptômes ne suffisent pas à identifier le type

On lit souvent « hydrogène = diarrhée, méthane = constipation, sulfure = gaz malodorants ». Ces tendances existent, mais elles ne sont pas fiables

individuellement : la sensibilité de l'intestin, l'alimentation, les médicaments et les hormones modifient le transit autant que le gaz. Deux personnes avec les mêmes symptômes peuvent produire des gaz différents, et l'inverse est vrai aussi.

PARTIE 1 · COMPRENDRE

Chapitre 4
SIBO, intestin irritable et autres explications.

Les symptômes digestifs ont de nombreuses causes possibles.

Le syndrome de l'intestin irritable (SII) est un diagnostic fondé sur des symptômes (douleurs abdominales associées à un changement de transit), posé après avoir écarté d'autres maladies. Le SIBO, lui, est un excès bactérien que l'on cherche à mesurer. Les deux se recoupent largement.

Selon certaines méta-analyses, jusqu'à 78 % des personnes ayant un SII auraient un SIBO. Mais ce chiffre varie fortement selon les tests utilisés, et la relation de cause à effet est discutée : le SIBO est-il la cause du SII, une conséquence, ou les deux partagent-ils une cause commune ? Les recommandations de l'American College of Gastroenterology reconnaissent cette incertitude.

Ce qui peut ressembler à un SIBO

- un syndrome de l'intestin irritable sans SIBO ;
- une intolérance au lactose ou au fructose ;
- une maladie cœliaque ou une sensibilité au gluten ;

- une constipation fonctionnelle, avec distension ;
- une hypothyroïdie ;
- des troubles liés au cycle hormonal ou à la périménopause ;
- des effets d'un médicament.

> **POURQUOI UN BILAN MÉDICAL D'ABORD**
>
> Plusieurs de ces situations se dépistent par une prise de sang ou un examen simple. Écarter une maladie cœliaque ou un trouble thyroïdien **avant** d'attribuer vos symptômes à un SIBO évite de suivre une fausse piste pendant des mois.

Les limites du test respiratoire

Les recommandations précisent que le test respiratoire a une sensibilité et une spécificité limitées. Dans une étude citée, l'accord avec le prélèvement direct n'était que d'environ 65 %. Un test positif n'est donc pas une preuve absolue, et un test négatif ne l'exclut pas. Il s'interprète toujours avec votre histoire.

PARTIE 1 · COMPRENDRE

Chapitre 5
SIBO et hormones : ce que l'on sait, et ce que l'on suppose.

Un sujet où il faut séparer la physiologie établie des hypothèses.

Ce qui est bien établi

- Les hormones sexuelles influencent le transit. Des variations de transit au cours du cycle menstruel sont décrites, ce qui explique que ballonnements et constipation fluctuent chez beaucoup de femmes.
- Le sexe féminin est cité comme facteur associé au SIBO dans les recommandations.
- Les symptômes digestifs sont fréquents dans le syndrome prémenstruel, le SOPK et l'endométriose, et les chevauchements avec le SII sont courants.

Ce qui relève d'hypothèses

L'« estrobolome » désigne l'ensemble des bactéries intestinales capables de modifier les œstrogènes, notamment par une enzyme appelée bêta-glucuronidase. Ce concept est étayé. Il explique pourquoi un microbiote déséquilibré pourrait influencer le niveau d'œstrogènes circulants. Mais le lien précis entre un SIBO et cette régulation n'est pas démontré.

De même, des associations entre SIBO et SOPK, endométriose ou problèmes thyroïdiens sont observées dans de petites études. On ne sait pas toujours dans quel sens va le lien : un trouble hormonal peut favoriser un SIBO, un SIBO peut aggraver des symptômes, ou une cause commune peut agir sur les deux.

> **POURQUOI JE LE PRÉCISE**
>
> Vous trouverez sur Internet des affirmations catégoriques sur les liens entre SIBO et hormones. La réalité est plus nuancée : ces liens sont plausibles et méritent d'être explorés avec vous en consultation, mais ils ne sont pas des certitudes. Une démarche honnête commence par le dire.

PARTIE 2 · TESTER

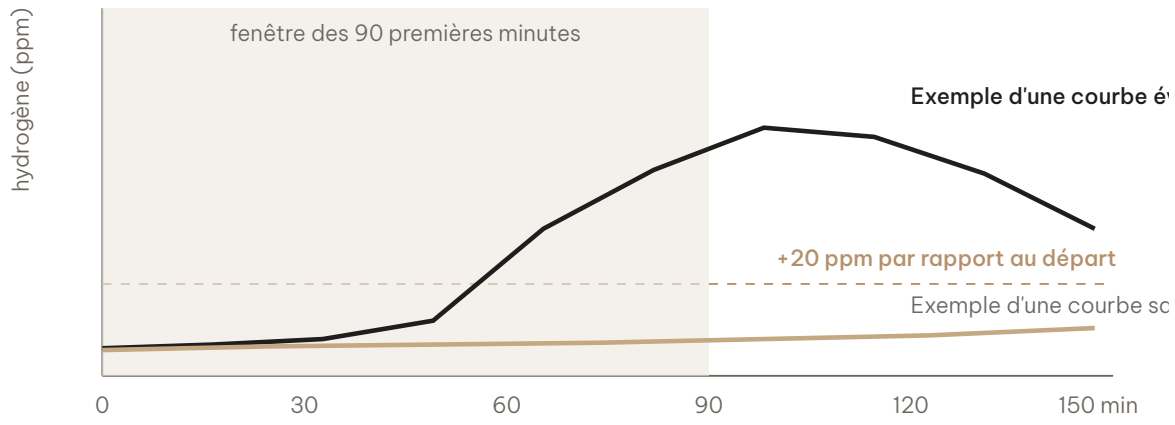
Chapitre 6
Le test respiratoire, pas à pas.

Mesurer plutôt que deviner.

Comment cela fonctionne

Vous buvez une solution de sucre (lactulose ou glucose). Si des bactéries sont présentes en excès dans l'intestin grêle, elles la fermentent et produisent des gaz. Une partie de ces gaz passe dans le sang, puis dans l'air que vous expirez. On le mesure à intervalles réguliers (souvent toutes les 15 à 20 minutes, selon les protocoles) pendant 2 à 3 heures.

Les doses de référence sont de 10 g de lactulose ou de 75 g de glucose, avec un verre d'eau. Le critère le plus utilisé est une élévation de l'hydrogène d'au moins 20 ppm par rapport à la valeur de départ dans les 90 premières minutes. Pour le méthane, un niveau d'au moins 10 ppm est considéré comme positif.



Exemple schématique (valeurs fictives). La courbe foncée dépasse de plus de 20 ppm la valeur de départ avant 90 minutes : c'est le type de profil considéré comme évocateur. La courbe claire reste plate.

Comment le demander

Le test se demande à un médecin : médecin traitant ou gastro-entérologue. Précisez que vous souhaitez un test respiratoire à l'hydrogène et au méthane, au lactulose ou au glucose. Sa disponibilité varie selon les régions et les établissements : renseignez-vous auprès de votre médecin sur les centres proposant ce test près de chez vous.

POURQUOI JE RECOMMANDE DE LA PRUDENCE AVEC LES KITS VENDUS EN LIGNE

Un test dont la méthode, le substrat et la préparation ne sont pas clairement décrits, ou qui n'est pas interprété par un professionnel, peut donner un résultat inexploitable ou trompeur. Privilégiez un test prescrit, avec une consigne de préparation écrite, et un résultat commenté.

Comment le préparer

La préparation conditionne la fiabilité du résultat. Les recommandations internationales indiquent :

- **Antibiotiques :** les éviter pendant les 4 semaines qui précèdent. Cette recommandation est forte.
- **Laxatifs et traitements qui stimulent le transit :** les arrêter au moins une semaine avant, si votre médecin l'estime possible. Ne les arrêtez jamais seul·e.
- **La veille :** éviter les aliments très fermentescibles, selon la consigne écrite remise par le laboratoire. Suivez-la précisément.
- **À jeun :** une période de jeûne de 8 à 12 heures avant le test.
- **Le jour du test :** ne pas fumer, et limiter l'activité physique.
- **Probiotiques :** il n'existe pas de consensus. Demandez la consigne du laboratoire.

> **POURQUOI CELA CHANGE TOUT**
>
> Si des aliments fermentescibles sont encore dans votre intestin, ou si des bactéries du côlon sont stimulées, la valeur de départ est plus haute et la courbe devient difficile à lire. Un test mal préparé peut être faussement positif ou rendre le résultat ininterprétable.

PARTIE 2 · TESTER

Chapitre 7
Lire un résultat, et savoir ce qu'il ne dit pas.

Un résultat est une information, pas un verdict.

CE QUE VOUS VOYEZ	CE QUE CELA PEUT VOULOIR DIRE	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
Élévation de l'hydrogène d'au moins 20 ppm avant 90 min	Évocateur d'un excès bactérien dans l'intestin grêle.	La qualité de la préparation, votre transit (un transit très rapide peut brouiller la lecture), vos symptômes.
Méthane d'au moins 10 ppm	Évocateur d'un excès de micro-organismes producteurs de méthane (IMO).	À discuter si vous êtes constipé·e. Le méthane influence le transit.
Valeur de départ élevée	Peut traduire une préparation insuffisante, ou une fermentation déjà présente.	L'interprétation d'une valeur de départ élevée reste discutée : ne la lisez pas seul·e.
Courbe plate	Pas d'argument pour un excès d'hydrogène ou de méthane.	Cela n'exclut pas un profil à sulfure d'hydrogène, que ce test ne mesure pas.

POURQUOI JE NE PROPOSE PAS DE GRILLE D'INTERPRÉTATION « MAISON »

Les seuils ci-dessus sont les critères de consensus. Mais l'interprétation fine dépend du substrat utilisé, de votre transit, de la préparation et de vos symptômes. C'est le rôle du médecin qui a prescrit le test, et de la discussion avec votre praticien·ne.

FICHE IMPRIMABLE

Lire mes résultats.

À remplir avec le compte rendu du laboratoire. Cette fiche sert à organiser les informations, pas à poser un diagnostic.

TEMPS	HYDROGÈNE (PPM)	MÉTHANE (PPM)
0 min (départ)		
20 min		
40 min		
60 min		
80 min		
90 min		
120 min		
150 min		

INFORMATIONS UTILES

Substrat utilisé	
Date, laboratoire	
Traitements en cours	
Préparation suivie (oui / à vérifier)	

MES QUESTIONS POUR MON MÉDECIN OU MON PRATICIEN·NE

PARTIE 3 · AGIR, AVEC MÉTHODE

Chapitre 8
La logique d'un accompagnement.

Ce guide explique l'ordre des choses, pas un protocole.

Quand un excès bactérien est identifié, une démarche cohérente suit généralement quatre temps. L'ordre a une logique : on ne ferme pas la porte avant de savoir pourquoi elle est ouverte.

TEMPS	OBJECTIF	POURQUOI CET ORDRE
1 · Comprendre	Identifier la cause probable, écarter d'autres maladies, confirmer l'excès par un test.	Traiter sans cause identifiée expose à la rechute.
2 · Réduire la charge bactérienne	Diminuer l'excès, avec les moyens adaptés à votre situation.	Le choix dépend de votre profil de gaz, de votre état de santé et de vos traitements.
3 · Soutenir ce qui protège	Aider l'intestin à retrouver ses défenses : nettoyage, motricité, rythme.	C'est cela qui limite le retour des bactéries.
4 · Prévenir	Surveiller, ajuster, traiter la cause de fond.	La rechute est fréquente si la cause persiste.

Ce que disent les recommandations médicales

Pour les personnes symptomatiques ayant un SIBO, les recommandations américaines proposent un traitement antibiotique, pour éliminer l'excès bactérien et soulager les symptômes (niveau de preuve faible). Elles précisent que les retraitements reposent surtout sur l'avis d'experts. D'autres

approches, notamment à base de plantes, ont été étudiées dans de petites études, mais leur place précise ne peut pas être tranchée à ce jour.

POURQUOI JE NE DÉTAILLE PAS DE TRAITEMENT ICI

Le choix, la durée et la surveillance d'un traitement dépendent de votre type de gaz, de votre état de santé, de vos traitements et de votre histoire. Un traitement antibiotique relève d'un médecin. Une approche naturelle bien choisie peut aider, mais mal choisie, elle peut gêner ou interagir avec un médicament. C'est exactement ce que l'on précise en consultation, et c'est pourquoi aucun guide ne peut le faire à votre place.

PARTIE 3 · AGIR, AVEC MÉTHODE

Chapitre 9
L'alimentation : ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas.

Une alimentation restrictive soulage parfois, mais elle ne traite pas la cause.

Les FODMAPs sont des glucides fermentescibles (oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols) que l'intestin absorbe mal. Une alimentation pauvre en FODMAPs diminue la quantité de substrat disponible pour les bactéries, donc la fermentation, donc les gaz. C'est pourquoi elle soulage fréquemment le syndrome de l'intestin irritable.

Ce que l'on sait

- Ce type d'alimentation peut réduire les symptômes, y compris en cas de SIBO.
- Les recommandations américaines précisent que les preuves dans le SIBO sont de très faible qualité : elles sont extrapolées du syndrome de l'intestin irritable.
- Le régime pauvre en FODMAPs a été conçu comme une démarche en trois temps (restriction limitée dans le temps, réintroduction, personnalisation), pas comme un régime permanent.

Ce que l'on ne sait pas, ou ce qui pose problème

- Il traite les symptômes, pas la cause : si l'excès bactérien persiste, les symptômes reviennent à la réintroduction.
- Une restriction prolongée peut appauvrir l'alimentation, les apports en fibres et la diversité du microbiote, et entretenir la peur de manger.
- Il n'existe pas de liste valable pour tout le monde : les aliments qui posent problème varient d'une personne à l'autre.

PRUDENCE : ANTÉCÉDENTS DE TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Si vous avez déjà eu un trouble du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie, restriction, orthorexie), ou si vous vous sentez à risque, **n'entamez pas de régime restrictif seul·e**. Parlez-en d'abord à votre médecin ou à un professionnel formé à ces situations. Une période de restriction, même motivée par une raison digestive, peut réactiver d'anciens schémas.

Il en va de même si vous êtes enceinte, si votre poids est bas, ou si vous suivez un traitement dont l'effet dépend de l'alimentation (diabète, par exemple).

POURQUOI JE NE DONNE NI LISTE D'ALIMENTS NI MENU TYPE

Parce qu'une liste « à éviter, à privilégier » est faite pour une moyenne qui n'existe pas. Elle peut vous faire retirer des aliments inutilement, ou en conserver qui vous posent problème. L'alimentation se construit à partir de vos symptômes, de votre histoire et de votre terrain, avec un suivi, et surtout avec une phase de réintroduction pour ne pas rester dans la restriction.

PARTIE 3 · AGIR, AVEC MÉTHODE

Chapitre 10
Le rythme des repas et le nettoyage de l'intestin.

Comment on mange compte autant que ce que l'on mange.

Rappelez-vous le complexe moteur migrant (chapitre 2) : cette vague de nettoyage ne se produit qu'à jeun, et chaque repas ou grignotage l'interrompt. Manger en continu, même sainement, laisse donc moins d'occasions à l'intestin grêle de se nettoyer.

De là vient l'idée de laisser des intervalles sans manger entre les repas. Son raisonnement physiologique est cohérent. En revanche, **les preuves cliniques sont modestes** : il s'agit surtout d'une logique de physiologie et d'une pratique d'experts, pas d'un résultat démontré par de larges essais.

> **QUAND CE N'EST PAS ADAPTÉ**
>
> Ne modifiez pas votre rythme de repas sans avis médical si vous êtes enceinte ou allaitante, si votre poids est bas, si vous avez un diabète traité, ou si vous avez des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Pour ces situations, un intervalle trop long peut être inadapté, voire dangereux.

Ce que cela change dans la pratique

L'idée n'est pas de vous priver. Elle est de repérer si vous mangez ou grignotez de façon quasi continue et de comprendre pourquoi : faim réelle, habitude, stress, repas trop légers. La réponse n'est pas la même pour tout le monde, et c'est ce que l'on regarde ensemble.

Chapitre 11
Stress, nerf vague et sommeil.

Le nerf vague régule en partie la motricité digestive, et le système nerveux autonome influence le nettoyage de l'intestin. Un stress prolongé ou un

sommeil perturbé modifient ces régulations. Cette piste est plausible et fréquemment évoquée. Les données directes dans le SIBO restent limitées.

Ce que l'on peut dire sans exagérer : des pratiques simples d'apaisement (respiration lente, marche, régularité du sommeil) n'ont pas de risque et peuvent améliorer le confort digestif de beaucoup de personnes, en agissant sur la sensibilité de l'intestin et sur le stress. Elles ne remplacent pas la recherche de la cause.

PARTIE 3 · AGIR, AVEC MÉTHODE

Chapitre 12
Compléments et probiotiques : pourquoi cela ne se décide pas dans un guide.

Ni toujours utiles, ni toujours à éviter.

Sur Internet, on lit tout et son contraire : « les probiotiques aggravent le SIBO », « ils le guérissent ». Ce que disent les recommandations médicales est plus sobre : **il n'existe pas de données cohérentes pour recommander des probiotiques précis dans le SIBO**. Les essais sont petits, de qualité inégale, avec des résultats contradictoires, et des effets indésirables ont été rapportés.

La même prudence s'applique aux compléments en général. Leur effet dépend de la dose, de la forme, du moment, de la personne et de ses traitements. Un produit utile pour l'une peut gêner une autre, ou interagir avec un médicament.

POURQUOI JE NE DONNE AUCUN NOM DE PRODUIT

Parce que le bon choix dépend de votre situation, de votre profil de gaz, de vos traitements et de vos examens. Il se décide avec un professionnel qui connaît l'ensemble. Si vous prenez déjà des compléments, notez-les avec leur dose : c'est une information essentielle pour votre médecin et pour moi.

Chapitre 13
La rechute, et comment la prévenir.

La rechute est le point faible de la prise en charge. Dans une étude menée sur 80 adultes traités par antibiotiques, le SIBO était réapparu chez environ 13 % des personnes à 3 mois, 28 % à 6 mois et 44 % à 9 mois. Ce sont des données d'un groupe particulier, donc elles ne s'appliquent pas à tout le monde, mais elles montrent que le risque est réel.

La prévention repose sur la compréhension du premier domino : un traitement médicamenteux au long cours à réévaluer avec votre médecin, un trouble de la motricité, une cause hormonale ou thyroïdienne à explorer, un rythme de repas à ajuster. C'est pourquoi la fiche de la frise (page suivante) est l'outil le plus utile de ce guide.

PARTIE 4 · VOTRE HISTOIRE

Ma frise du premier domino.

Placez sur cette frise les événements qui ont marqué votre santé : chirurgies, antibiotiques longs, infections digestives, grossesses, traitements, périodes de stress intense, changements hormonaux. Cherchez ce qui s'est passé avant l'apparition des symptômes.

PÉRIODE	ÉVÉNEMENTS, TRAITEMENTS, SYMPTÔMES
Enfance	
Adolescence	
20-30 ans	
30-40 ans	
40-50 ans	
Aujourd'hui	

QUESTIONS POUR REPÉRER LE PREMIER DOMINO

- Une infection digestive sévère a-t-elle précédé le début des symptômes ?
- Ai-je pris des antibiotiques de façon prolongée ou répétée ?
- Ai-je subi une chirurgie abdominale ?
- Ai-je pris un traitement contre l'acidité de l'estomac sur une longue durée ?

- Ai-je un trouble thyroïdien, un diabète, un SOPK, de l'endométriose ?
- Une période de stress intense ou de bouleversement a-t-elle précédé les symptômes ?

FICHE IMPRIMABLE

Mon journal de 7 jours.

Notez, sans interpréter. Ce journal aide votre médecin ou votre praticien·ne à repérer des tendances (horaires, repas, stress, cycle). Remplissez-le chaque soir.

JOUR	REPAS ET HEURES	SYMPTÔMES (0 À 10)	TRANSIT	STRESS, SOMMEIL, CYCLE
J1				
J2				
J3				
J4				
J5				
J6				
J7				

FICHE IMPRIMABLE

Préparer mon rendez-vous.

Un rendez-vous dure peu de temps. Arriver avec des informations claires aide à obtenir des réponses précises.

À APPORTER

- La liste de mes traitements et compléments, avec les doses.
- Mes résultats d'analyses récents et le compte rendu de mon test respiratoire s'il existe.
- Ma frise du premier domino et mon journal de 7 jours.

QUESTIONS À POSER

- Mes symptômes justifient-ils un test respiratoire ? Avec quel substrat ?
- Faut-il d'abord écarter une autre cause (maladie cœliaque, thyroïde, intolérance) ?
- Mes traitements actuels peuvent-ils favoriser mes symptômes ? Peuvent-ils être réévalués ?
- Si le test est positif, quelles options proposez-vous, et comment le suivi sera-t-il organisé ?
- Quels signes doivent me faire consulter rapidement ?

MES NOTES

RÉFÉRENCE

Glossaire.

CMM	Complexe moteur migrant : vague de contractions qui nettoie l'intestin grêle à jeun.
Dysbiose	Déséquilibre de la composition ou du fonctionnement du microbiote intestinal.
Estrobolome	Ensemble des bactéries intestinales capables de modifier les œstrogènes.
FODMAPs	Glucides fermentescibles mal absorbés qui nourrissent les bactéries intestinales.
IMO	Intestinal Methanogen Overgrowth : excès de micro-organismes producteurs de méthane.
IPP	Inhibiteurs de la pompe à protons : traitements qui diminuent l'acidité gastrique.
Perméabilité intestinale	Capacité de la paroi de l'intestin à laisser passer des substances. Son rôle dans les symptômes reste débattu.
ppm	Parties par million : unité de mesure des gaz expirés.
SII	Syndrome de l'intestin irritable : trouble fonctionnel fondé sur des symptômes.
SIBO	Small Intestinal Bacterial Overgrowth : excès de bactéries dans l'intestin grêle.
Valvule iléo-cæcale	Valve entre l'intestin grêle et le côlon.

Sources.

Ce guide est un document de vulgarisation. Les affirmations chiffrées et les recommandations qu'il cite proviennent des publications suivantes. Les points présentés comme des hypothèses ou comme discutés sont indiqués comme tels dans le texte.

- Pimentel M, Saad RJ, Long MD, Rao SSC. ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth. *Am J Gastroenterol*. 2020;115(2):165-178.
- Rezaie A, Buresi M, Lembo A, et al. Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. *Am J Gastroenterol*. 2017;112(5):775-784.
- Lauritano EC, Gabrielli M, Scarpellini E, et al. Small intestinal bacterial overgrowth recurrence after antibiotic therapy. *Am J Gastroenterol*. 2008;103(8):2031-2035.
- Takakura W, Pimentel M. Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome: An Update. *Front Psychiatry*. 2020;11:664.
- Gibson PR, Shepherd SJ. Evidence-based dietary management of functional gastrointestinal symptoms: the FODMAP approach. *J Gastroenterol Hepatol*. 2010;25(2):252-258.
- Baker JM, Al-Nakkash L, Herbst-Kralovetz MM. Estrogen–gut microbiome axis: physiological and clinical implications. *Maturitas*. 2017;103:45-53.

avitaserena.

Pour aller plus loin, je propose un bilan de vitalité de 90 minutes en visio depuis Porto-Vecchio, en lien avec votre suivi médical.
Réservation sur avitaserena.com/reservation · sabrina@avitaserena.com

© 2026 A VITA SERENA · Sabrina Castelli. Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il a un objectif éducatif et ne constitue ni un diagnostic médical, ni un traitement.